

INDICADO POR: Flávio
() ACOMPANHAMENTO (X) CONSULTA
NS

CARLOS GIOVANNI MACHADO

IDADE: 53 PESO: 102 ALTURA: 175 PROFISSÃO: Advogado
SINTOMAS: Sonolência diurna / cansaço / Relata que a concentração está ruim.
QUEIXAS: Acorda cansado e espora se incomoda qd o sono
MEDICAMENTOS: Rosuvastatina / Purin T4.

MÉDICO: Dr. Flávio / Dr. Zisel

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 (17:00) JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7hrs. espora

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE ruma

TEM FILHOS: (X) S () N 3 / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N 1

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —

OVERLAP: negativa MALLAMPATI: IAH: 64.2 SPO2: 90%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: negativa IDO = 28,8 efv

CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA Derrub septo.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Cirurgia ameno / mão.

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA Dor no abd. v

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: 10 PRESSÃO NO EXAME: 34.6

IDO = 16,7

Dr. Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

CRM 100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Doutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Carlos Giovanni Machado

Solicito:

- Adaptação de CPAP a pressão inicial de 9cmH2O

CID G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: CARLOS GIOVANNI MACHADO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 16-09-2025

Idade: 53 anos

Peso: 104 kg

Altura: 1,75 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 16/09/2025 22:18 e finalizado às 17/09/2025 05:39.

A latência para início do sono foi de 2,3 min e a latência para o sono REM de 24,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 209,5 min, com eficiência do sono de 97,9 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,2 % de estágio N1, 59,4 % de estágio N2, 10,7 % de estágio N3 e 28,6 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 2,1 min. Ocorreram 187 despertares, sendo o índice de 25,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 224, sendo 123 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 101 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 64,2 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 43,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 72,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 64,2 (nº/h), sendo 35,2 apneia/h e 28,9 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 95% e a mínima de 90%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 28,8 (nº/h), sendo que em REM foi de 41,0 (nº/h) e em NREM foi de 68,6 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**64,2 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**90%**);
3. Latência para o início do sono diminuída (**2,3 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM diminuída (**24,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (**97,9 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares (**25,4 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**59,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**10,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM (**28,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

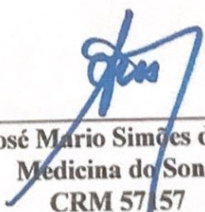
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico Split-night, na segunda metade da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: CARLOS GIOVANNI MACHADO

Data do Exame: 16-09-2025

pág. 2

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: CARLOS GIOVANNI MACHADO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 16-09-2025

Idade: 53 anos

Peso: 104 kg

Altura: 1,75 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 16/09/2025 22:18 e finalizado às 17/09/2025 05:39.

A latência para início do sono foi de 0,0 min e a latência para o sono REM de 62,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 220,0 min, com eficiência do sono de 96,6%.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,6 % de estágio N1, 53,0 % de estágio N2, 22,5 % de estágio N3 e 23,0 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 7,7 min. Ocorreram 78 despertares, sendo o índice de 10,6 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 127, sendo 29 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 98 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 34,6 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 66,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 25,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 34,6 (nº/h), sendo 7,9 apneia/h e 26,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 94% e a mínima de 84%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 16,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 64,2 (nº/h) e em NREM foi de 24,4 (nº/h). Permaneceu 2,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**34,6 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**84%**);
3. Latência para o início do sono diminuída (**0,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM diminuída (**62,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (**96,6 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**10,6 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,6 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**53,0 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**22,5 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**23,0 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

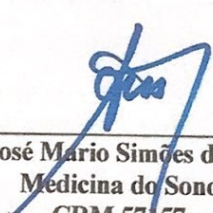
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico Split-night evidenciando na primeira metade da noite apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157